

Monotropismul și pânza sa de comorbiditate: legături directe și indirecte la condiții comportamentale, psihiatrice și neurodezvoltare

Un dosar de cercetare citat.

Rezumat

Monotropismul (Murray, Lawson & Lesser, 2005) este o teorie a atenției autiste care încadrează autismul ca o diferență de *alocare a resurselor*: o minte monotropă concentrează resurse de procesare într-un număr mic de „tuneluri de atenție” intens activate, lăsând mai puține resurse pentru canalele periferice. O măsură de auto-raportare din 2023 —

Monotropism Questionnaire (MQ) — oferă prima validare empirică, arătând că oamenii autiști și cu ADHD scor semnificativ mai mare decât controalele non-autiste/non-ADHD [1][2][3]. Un model apropiat evaluat de colegi, contul de **alocare atipică a resurselor** al lui Goldknopf, argumentează că aceeași atenție îngustă-intensă poate lega trasăturile senzoriale, sociale, executive și motorii ale autismului — avertizând că este „cel mai probabil un factor la oamenii autiști cu simptome senzoriale puternice”, nu cauza unică [4].

Pentru că monotropismul este o teorie despre *cum sunt cheltuite resursele*, plauzibil revarsă în multe domenii. Tabloul sincer, totuși, se împarte în trei niveluri:

- **Nivelul 1 — Legături directe, empiric susținute.** Suprapunerea autism–ADHD („AuDHD”) este cea mai puternică: MQ arată că atenția monotropă este ridicată în *ambele* condiții, reîncadrând „scindarea monotropă” (tuneluri concurente sau instabile) ca un fenotip de

atenție real, măsurabil [2][3][5]. Suprapunerile la nivel de mecanism — **interocepția** atipică și **disfuncția executivă** — sunt bine evidențiate și ajută la explicarea problemelor din aval cu alimentație, dezordine și evitare [6][7][8].

- **Nivelul 2 — Comorbiditate indirectă, mecanism comun.** Autismul se suprapune marcat cu **anorexia/alimentația restrictivă** și **TOC**. În fiecare caz comorbiditatea este reală și replicată, dar *cea mai bine demonstrată* punte este un mecanism comun (interocepție; procesare ego-sintonică vs ego-distonică) mai degrabă decât monotropismul specific [6][9][10].
- **Nivelul 3 — Extrapolare plauzibilă sau constructe contestate.** Unele legături în cadrul popular — „grămezi de doom” ca un eșec de permanență a obiectului monotrop, agorafobia ca rezultat monotrop primar, **PDA** ca profil distinct — se bazează pe dovezi mai slabe sau contestate și ar trebui tratate ca ipoteze, nu fapte stabilite [11][12][13].

De-a lungul, o temă recurentă: multe comportamente care arată ca „tulburări” separate se citesc mai bine ca **costul cognitiv al unui sistem de atenție îngust în coliziune cu o lume polyiotropă** — dar doar unele din acele lecturi au fost testate direct.

1. Fundații: ce este monotropismul și cât de solid este

Monotropismul propune că mințile diferă în cum distribuiesc resursele de atenție. O minte **polyiotropă** menține multe canale de interes active simultan (largă, superficială, comutare ușoară); o minte **monotropă** canalizează resurse în câteva „tuneluri de atenție” intens activate (îngustă, profundă, greu de comutat) [1][3]. Creatorii — Dinah Murray, Wenn Lawson și Mike Lesser — au prezentat ideea prima dată la conferințele Durham despre autism din 1992 și au formalizat-o în 2005, argumentând că explică trăsăturile autiste (interese speciale, nevoie de identitate, stres la tranziții, focus pe detaliu) mai bine decât modelele doar-deficitare [1][14].

Statutul său științific s-a schimbat în ultimii ani:

- Este **empiric măsurabil**. MQ (Garau et al., 2023) este un instrument de auto-raportare cu 47 itemi testat pe 1.110 participanți (756 autiști,

354 non-autiști). Participanții autiști și cu ADHD au scor semnificativ mai mare decât controalele [2][3].

- Are o **verișoară mecanistică evaluată de colegi**. Modelul de „alocare atipică a resurselor” al lui Goldknopf (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operaționalizează intuiția: în autism, resursele de atenție sunt **îngustate** (către mai puține/mai mici arii, modalități și stadii de procesare, uneori mai intens) și/sau **reduse** în capacitate globală — un cadru care explicit leagă limbaj, cogniție socială, atipicalitate senzorială/de atenție și diferențe executive/motorii [4].
- Stă **alături, nu în locul**, altor teorii cognitive (Teoria Minții; coerență centrală slabă / stil cognitiv centrat pe detaliu (Happé & Frith, 2006); disfuncție executivă) [4][15].
- Este încă un **model, nu un biomarker**. Goldknopf este explicit că este un factor printre mai multe, „cel mai probabil” salient la oamenii autiști cu simptome senzoriale puternice [4]. Murray și colegi încadrează similar monotropismul ca o *lentilă* unificatoare, nu o etiologie completă [1][14].

Implicație pentru restul acestui dosar: monotropismul este o idee organizatoare credibilă, din ce în ce mai validată, dar *riașul său explicativ* în fiecare comorbiditate trebuie argumentat caz cu caz — nu prezumat.

2. Nivelul 1 — Legături directe: clusterul neurodezvoltare

2.1 AuDHD și „scindarea monotropă” (*cea mai puternică legătură directă*)

Autismul și ADHD co-apar mult mai des decât ar prezice norocul: ADHD este prezent la aproximativ **30–80%** din oamenii autiști, și autismul la aproximativ **20–50%** din cei cu ADHD [5]; o metaanaliză plasează ratele de simptome ASD în eșantioane ADHD în jur de **21%** [16]; un studiu Medicaid mare a constatat că **27%** din adulții autiști fără dizabilitate intelectuală aveau un diagnostic ADHD co-apariție — aproximativ 10× rata generală [17]. Suprapunerea este substanțial genetică (~50–72%) [18].

Monotropismul ajută la rezolvarea unei vechi enigme: dacă autismul este „hiper-focus” și ADHD este „neatenție”, de ce co-apar? MQ răspunde empiric — **oamenii cu ADHD, mai ales AuDHD, sunt de asemenea puternic monotropi** [2][3]. Hiperfocus-ul în ADHD (Grotewiel et al., 2022) este conceptual aproape identic cu tunelul monotrop [19]. Cadrul „scindării monotrope” prin urmare reîncadrează AuDHD nu ca opuse ci ca **un sistem instabil de tuneluri de atenție concurente sau cu comutare rapidă**: creierul cere focus monotrop profund dar nu poate stabiliza tunelul, producând oscilația AuDHD familiară între angajament intens, burnout rapid și sub-stimulare cronică [19][20].

Rezervă: mecanismul „tunelurilor concurente multiple” este *plauzibil și consistent cu datele MQ* dar încă nu testat direct ca dinamică; ar trebui citit ca o ipoteză puternică.

2.2 Burnout autist și ruptura de tunel

Burnout-ul autist — epuizare cronică, pierdere de abilități și toleranță redusă — este din ce în ce mai legat de costul cumulativ al comutării constante de tunel, mascherie și cereri depășind capacitatea, cu timp insuficient de recuperare/flux [20][21]. Acesta este un domeniu unde monotropismul este euristic puternic (fiecare tranziție forțată este o ruptură de tunel), deși literatura burnout-ului în sine este încă în maturare și calea monotropism→burnout este în mare parte clinică/din prima persoană mai degrabă decât stabilită experimental [20].

2.3 Evitarea cererii și PDA (*construct contestat*)

O cerere — „pregătește-te”, „fă acest formular” — poate fi experimentată ca o intruziune violentă într-o stare de flux. Acesta este contul monotrop intuitiv de **evitare a cererii**. Constructul mai specific **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, inventat de Elizabeth Newson în anii 1980 și acum adesea reîncadrat ca „Pervasive Drive for Autonomy”, descrie o nevoie condusă de anxietate de control și evitare a cererilor obișnuite [11][22].

Două lucruri trebuie separate:

- **Comportamentul de evitare a cererii este real și comun** în autism, iar contul monotrop de „ruptură de tunel” este o *poveste mecanistică* rezonabilă pentru panica și rezistența pe care le produce.

- **PDA ca profil sau subtip distinct nu este stabilit.** National Autistic Society din Marea Britanie afirmă „nici o cercetare nu a găsit dovadă puternică pentru [PDA] ca profil distinct” [11]; studiul fondator al lui Newson a fost criticat pentru **raționament circular și suprainterpretare** (grupuri definite de cercetători au fost apoi „studiate”) [12][13]; și recenziile notează probleme persistente cu definiția, validitatea constructului și măsurarea [23]. O revizuire din 2023 este intitulată punctat „*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*” [13].

Deci cadrul textului sursă este pe jumătate corect: *experiența* (o cerere sparge tunelul) este bine descrisă de monotropism; *entitatea diagnostică* (PDA) este contestată și nu ar trebui prezentată ca așezată.

3. Nivelul 2 — Comorbiditate indirectă, mecanism comun

3.1 Anorexie și alimentație restrictivă

Suprapunerea autism–anorexie este robustă și bidirecțională: aproximativ **20–30%** din pacienții cu tulburări de alimentație arată trasături autiste clinic semnificative, cu cele mai mari rate în anorexia nervoasă și ARFID [6][24]; invers, adulții autiști au rate ridicate de tulburări de alimentație. Crucial, trasăturile autiste sunt observate **înainte** de debutul TA, deci suprapunerea nu este doar un efect de înfometare [6].

Puntea *mecanică* cea mai bine demonstrată este **interocepția** — percepția semnalelor corpului intern (bătăie de inimă, sațietate). Interocepția atipică este implicată în etiologia *atât* autismului cât și a tulburărilor de alimentație și „poate, cel puțin parțial, fi responsabilă” pentru comorbiditatea lor [6]. Aceeași atipicalitate interoceptivă subjază **alexitimiei** (dificultate de a identifica/verbaliza emoții), prezentă la ~50% din oamenii autiști și ea însăși legată de patologie alimentară [7][8].

Unde se potrivește monotropismul (și unde nu): este rezonabil să spunem că o persoană monotropă adânc într-un tunel ar putea *rata* semnale de foame — dar afirmația specifică a textului sursă că „monotropismul reduce interocepția” supraestimează lanțul causal.

Relația demonstrată este **autism** → **interocepție/alexitimie atipică** → **vulnerabilitate alimentară**; monotropismul este o trăsătură paralelă a autismului, nu *cauza demonstrată* a diferenței interoceptive [6][7]. Urmărirea alimentelor/caloriilor poate de asemenea deveni un tunel de la sine, dar aceasta este mecanism-plauzibilă mai degrabă decât testată.

3.2 TOC vs hiper-focus: o distincție genuină

Autismul și TOC co-apar substanțial: ~17% din oamenii autiști îndeplinesc criteriile de TOC, vs ~1–2% în populația generală [9]. În ciuda similarității de suprafață (comportament repetitiv, rigiditate), **motorul afectiv diferă** și aceasta este bine stabilită clinic:

- Interesele și rutinele **autiste** restrictive/repetitive sunt tipic **ego-sintonice** — plăcute, auto-calmente, conduse de interes, adesea reglante.
- Compulsiunile **TOC** sunt **ego-distonice** — nedorite, conduse de anxietate, efectuate pentru a neutraliza rezultate temute [9][10].

Distincția textului sursă este prin urmare corectă și susținută de dovezi, și este confirmată direct de participanții autiști înșiși: într-un studiu calitativ au raportat că comportamentele repetitive sunt „parte din cine sunt”, pe când simptomele TOC „erau în conflict cu cum se văd pe ei înșiși” [10]. Același studiu încadrează potrivit co-apariția ca „*Autism is the arena and OCD is the lion*” — simptomele TOC pot „deturna” interesele speciale autiste, umflându-le intensitatea și distresul [10]. Monotropismul adaugă context (un tunel poate fi *capturat* de conținut TOC) dar diferențierea se bazează pe axa ego-sintonic/distonic, nu pe monotropism per se.

3.3 Anxietate și tulburări afective (substratul sub „agorafobie”)

Anxietatea este printre cele mai comune comorbidități ale autismului (o recenzie secundară citează ≥ 1 comorbiditate psihiatrică la ~86% din oamenii autiști) [25]. Două puncte de mecanism contează pentru clusterul comportamental de mai jos: (i) **hiper-reactivitatea senzorială** și anxietatea sunt legate, și prin *condiționare de context* produc **evitare comportamentală a locațiilor generalizate** (restaurante, magazine, petreceri) [26]; (ii) co-apariția frecventă a alexitimiei/dificultății interoceptive înseamnă că stările emoționale sunt adesea slab etichetate, alimentând anxietate difuză [7].

4. Nivelul 3 — Cluster comportamental/funcțional: dezordine, adunare, evitare, retragere socială

4.1 Dezordine, „grămezi de doom”, și disfuncție executivă

Fenomenul este bine susținut: oamenii autiști și cu ADHD arată rate ridicate de dezorganizare și dezordine, iar calea cea mai bine demonstrată este **disfuncția executivă** — deficite în categorisire, luare a deciziilor, planificare și memorie de lucru [8][27]. Simptomele de adunare sunt ridicate atât în ADHD (cu o „legătură specială cu neatenția” [8a]) cât și în autism [8]; în autism specific, lucru calitativ arată că dificultatea de a arunca este legată de **atașamente de interes și sens**, nu doar valoarea obiectului [28].

Rezervă la textul sursă: afirmația specifică că dezordinea persistă din cauza unui „deficit de permanență a obiectului” autist („din vedere, din minte”) **nu este susținută de dovadă evaluată de colegi** pe care am putut-o localiza. Permanența obiectului este tipic *intactă sau superioară* în autism; experiența „din vedere, din minte” se citește mai bine ca un efect de **memorie de lucru/alocație a atenției** (o minte tuneiată nu se reorientează la articole stocate) decât o eșec perceptual de permanență a obiectului. Mecanismul demonstrat pentru dezordine rămâne **disfuncție executivă plus atașament de interes**, care se suprapune cu populația monotropă/AuDHD dar nu este unic „monotropă” [4][8][28].

4.2 Comportament de spectrul adunării

Tulburarea de adunare afectează ~1,5–6% din populația generală dar este ridicată în autism [29]. La adulții autiști, dificultatea tip-adunare de a arunca este frecvent raportată alături de **dificultăți cognitive (executive) și atașamente puternice de interes/sens** — articolele sunt noduri într-o pânză de idei și utilitate viitoare, deci aruncarea se simte pierzanie [28]. Acesta este consistent cu un *stil* monotrop (procesare profundă a obiectelor) dar, din nou, motorul demonstrat este EF/atașament, comun peste condiții neurodezvoltare [8].

4.3 Agorafobie și delimitarea „spațiului sigur” (*necesită corectare*)

Textul sursă încadrează confinarea acasă agorafobică ca un rezultat monotrop aproape direct. Datele sunt mai nuanțate:

- Agorafobia este ridicată în autism — ~23–25% din adulții autiști (fără dizabilitate intelectuală) vs ~1,3% în populația generală — **dar este mai puțin comună decât fobia socială sau TAG**, iar efectul se concentrează la cei fără DI [25].
- Motorul mai bine demonstrat este **hiper-reactivitatea senzorială + anxietate socială**, cu evitare condiționată de context a locațiilor copleșitoare — i.e., comportamentul de „spațiu sigur” este real dar este **secundar anxietății senzoriale/sociale**, nu un fenomen monotrop primar [25][26].

Deci: monotropismul ajută să explice *de ce* lumea exterioară se simte perturbatoare (imprevizibilă, polyiotropă, sparge-tuneluri), dar clasificarea confinării rezultate ca „agorafobie” specifică monotropismului supraestimează legătura. Este o evitare condusă de anxietate senzorială care *se suprapune* cu experiența monotropă.

4.4 Retrageră socială, info-dumping, și problema dublei empatii

Interacțiunea socială este genuinely polyiotropă — cere urmărirea simultană a fețelor, ton, ierarhie, timing și reguli nescrise — deci este disproporționat de costisitoare pentru un sistem monotrop, un punct consistent cu modelul de resurse al lui Goldknopf [4]. Intuiția textului sursă este corectă.

Dar cadrul mai ascuțit, *empiric susținut*, pentru ruptura comunicațională rezultată este **problema dublei empatii** (Milton, 2012; 2017): dificultatea este *bidirecțională* și relațională — o „dezncrucișare în reciprocitate între doi actori sociali diferit dispuși” — nu un deficit unidirecțional de empatie în persoana autistă [30]. Lucru empiric arată acum că observatorii non-autiști *atât detectează cât și demonstrează* problema dublei empatii în interacțiuni mixte [31]. „Info-dumping” se potrivește natural: este comunicare care caută profunzime de la un sistem monotrop, care eșuează când partenerul nu poate egala profunzimea — o nepotrivire de stiluri de procesare, nu o lipsă de empatie [30][31].

Lacună de semnalat: literatura DEP exclude încă în mare copiii autiști, oamenii non-verbali și oamenii cu dizabilitate intelectuală, deci generalizarea este limitată [32].

5. Granița: unde contul monotrop ajunge prea departe

Afirmație în cadru sursă/laic	Statut dovadă	Cadru mai bun
Monotropismul <i>cauzează</i> trasăturile autismului	Parțial susținut (MQ; Goldknopf)	Un factor organizator validat printre mai multe; cel mai puternic în autism cu senzorial [1][4]
AuDHD = „scindare monotropă” (tuneluri concurente)	Puternic + direct măsurabil (MQ)	Un fenotip de atenție real; mecanismul dinamic este de nivel ipoteză [2][3]
PDA este un profil autist distinct	Contestat	Evitarea cererii este reală; PDA-ca-entitate lipsește validitate de construct [11][12][13]
Monotropismul <i>reduce interocepția</i> → anorexie	Indirect	Puntea este autism→interocepție/alexitimie→vulnerabilitate TA; monotropismul este paralel, nu cauza arătată [6][7]
Dezordine dintr-un „deficit de permanență a obiectului”	Nesusținut	Disfuncție executivă + atașament de interes; niciun deficit perceptual de permanență a obiectului evidențiat [4][8][28]
Agorafobie ca rezultat monotrop primar	Exagerat	Secundar hiper-reactivității senzoriale + anxietății sociale; mai puțin comun decât TAG/fobie socială [25][26]
TOC vs „obsesii” monotrope diferă prin afect	Bine susținut	Ego-distonic (TOC) vs ego-sintonic (interes autist); TOC poate „deturna” tuneluri [9][10]
Problema dublei empatii explică ruptura socială	Susținut (dar lacune)	Nepotrivire bidirecțională; eșantioane biruiesc spre adulți verbali fără DI [30][31][32]

6. Întrebări deschise

1. **Testare dinamică a tunelului.** MQ este o măsură de *trasătură*. Este „scindarea monotropă” (tuneluri concurente/instabile în AuDHD) observabilă în atenție/EEG în timp real? Larg netestat.
2. **Săgeată causală la interocepție.** Produce o distribuție de resurse monotrope *atipicalitate interoceptivă*, sau împărtășesc o cauză comună upstream? Dovada actuală nu le poate separa [6][7].
3. **Rezoluție PDA.** Va converge cercetarea evitării cererii pe un construct validat, măsurabil, sau va rămâne o categorie laică/clinică contestată? [11][13]
4. **Mecanismul dezordinii.** Este „din vedere, din minte” un efect de memorie de lucru/alocație (plauzibil) sau altceva? Niciun studiu dedicat găsit.
5. **Generalizabilitate DEP.** Cum operează problema dublei empatii pentru oamenii autiști non-verbali, copii și oameni cu dizabilitate intelectuală co-apariție? [32]
6. **Burnout.** Care este contribuția specifică, testabilă a rupturii de tunel monotrope la burnout-ul autist versus mascherie, traumă și cerere cronică? [20]

Surse

[1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2]
Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint). Comentariu/rezumato:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; oglindă: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — rezumat al constatărilor MQ (47 itemi; N=1.110; autiști + ADHD scor semnificativ mai mare): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — revizuire comorbiditate ADHD și autism (ADHD la ~30–80% din ASD; ASD la ~20–50% din ADHD; citează Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019): <https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsy.2025.1573263) — ~50% din oamenii autiști au alexitimie, mediată de deficite interoceptive.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] „legătura specială cu neatenția” este propriul subtitlu al lucrării. Vezi și Drake Institute despre ADHD/disfuncție executivă: <https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — rezumat systematic-review: ~17% din oamenii autiști îndeplinesc criteriile de TOC vs ~1–2% populație generală; distincție ego-sintonic vs ego-distonic: <https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (calitativ). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance („nici o cercetare nu a găsit dovadă puternică pentru [PDA] ca profil distinct”): <https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] Frontiers in Education (2024). Methods of studying PDA — critică a raționamentului circular al lui Newson (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020): <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed

36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (citată prin Frontiers 2024 studiu comparativ): <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of ASD symptoms in ADHD (citată prin Psych Scene Hub și Autistica): <https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17] Children's Hospital of Philadelphia — 27% din adulții autiști fără DI aveau ADHD co-apariție (~10× general): <https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — rezumat suprapunere genetică (~50–72%): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-adhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD ca tuneluri concurente; referințe Grotewiel et al. 2022 despre hiperfocus ADHD): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (stări de flux; referințe Heasman et al. 2024 „autistic flow theory”): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, anii 1980; reîncadrare „Pervasive Drive for Autonomy”): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O’Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (citează și Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobie în autism ~23–25% (fără DI) vs ~1,3% general; mai puțin comună decât fobie socială/TAG (sursă secundară, sprijinindu-se pe Helles et al. 2020 și Lugnegård et al. 2012): <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are->

[they-intrinsically-linked](#) [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — condiționare de context și evitare. PMC2980623. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (funcție executivă, luare decizii): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y., Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (calitativ). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636> [29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8> [30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) extindere. Rezumat: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy> [31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351> [32] Wikipedia — Double empathy problem (lacune de cercetare recunoscute: copii, non-verbali, dizabilitate intelectuală): https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Notă despre nivelurile de dovadă: Nivelul 1 = măsurare directă, replicată (MQ; rate AuDHD); Nivelul 2 = comorbiditate replicată cu un mecanism comun demonstrat; Nivelul 3 = extrapolare plauzibilă, sursă singulară sau construct contestat. Vezi §5.